

Transitorisk iskemisk atakk (TIA)

Bakgrunn

Regional iskemi i hjernen, ryggmargen eller retina med forbigående nevrologiske symptomer uten at det foreligger infarkt. Symptomene går vanligvis tilbake innen 60 minutter.

Symptomer og funn

Akutte fokalnevrologiske utfall som går helt tilbake innen 24 timer. Eksempler på utfall er hemiparese, sentral facialisparese, halvsidig sensibilitetsutfall, dysfasi, dysartri, synsfeltutfall eller generelt nedsatt syn på ett øye. Mistenk også TIA ved svimmelhet i kombinasjon med ataksi, dobbeltsidig synsforstyrrelse, dobbeltsyn, droppatakk eller dysartri.

Supplerende undersøkelser

- **Blodsukker** for å utelukke hypo- og hyperglykemi.
- **ABCD2 skår** for vurdering av risiko for hjerneslag kan brukes for å predikere risiko for etterfølgende hjerneslag. 0–3 tilsier lav risiko mens 4–7 tilsier høy risiko.

Risikofaktor	Kategori	Poeng
(A) Age	Alder ≥ 60 år	1
	Alder < 60 år	0
(B) Blood pressure	Systolisk BT > 140 mmHg eller diastolisk BT > 90 mmHg	1
	Lavere BT	0
(C) Clinical features	Halvsidig lammelse	2
	Språk/taleforstyrrelse uten lammelser	1
	Ingen lammelser/språkforstyrrelser	0
(D) Duration of symptoms	>60 min	2
	10–59 min	1
	<10 min	0
(D) Diabetes	Diabetes til stede	1
	Ingen diabetes	0
Total skår (maksimalt 7)		

Differensialdiagnoser

- [Hypoglykemi](#)
- [Migrene](#)
- Epilepsi
- Hjerterytmeforstyrrelse
- Hodetraume
- [Meningitt](#)
- Forgiftning
- [Encefalitt](#)
- Sykdom i det indre øret som gir svimmelhet:
 - [BPPV](#)
 - [Vestibularisnevritt](#)
 - [Ménière's sykdom](#)

Tiltak

- **Innleggelse.** Pasienter med symptomer på TIA bør utredes og behandles raskt, og akuttinnleggelse anbefales vanligvis uavhengig av ABCD2 skår. Konferer med ansvarlig sykehuslege.
- **Acetylsalisylsyre.** Gi 300 mg acetylsalisylsyre så raskt som mulig, uavhengig av om pasienten allerede bruker acetylsalisylsyre.
- **Øvrige** tiltak som for hjerneslag.

Komplikasjoner

Økt risiko for nye TIA, hjerneslag og infarkt. Størst risiko første 48 timer etter indeksepisode.